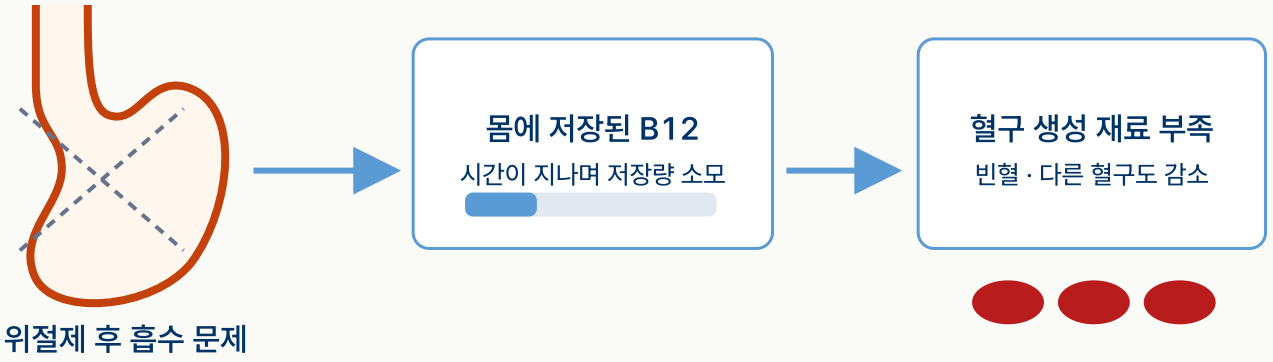
위 수술 뒤 비타민 B12, 오래 지나도 챙겨야 합니다

수술 직후 괜찮았더라도 몸에 저장된 비타민을 쓰면서 나중에 결핍이 드러날 수 있습니다.

저장량이 있어 결핍이 늦게 드러납니다



위절제 후 흡수 문제가 생기면 저장된 비타민 B12를 쓰다가 혈구 생성에 필요한 재료가 부족해질 수 있습니다.

빈혈 하나만 생기는 것은 아닙니다

살펴볼 변화	의미
혈색소 저하 · 큰 적혈구	거대적아구성 빈혈: 비타민 B12·엽산 부족 등으로 혈구를 제대로 만들기 어려운 상태입니다.
백혈구 · 혈소판도 함께 감소	비타민 B12 결핍이 심하면 세 종류의 혈구가 함께 줄어드는 범혈구감소증으로 나타날 수 있습니다.
피로감 · 운동할 때 숨참	강의의 위전절제 후 빈혈 증례에서 나타난 증상입니다. 수술 시기와 보충 이력을 함께 알립니다.

강의 속 사례: 위전절제 8년 뒤의 빈혈

73세 남성, 6개월간 피로감·운동 시 숨참

위암으로 위전절제 후 **8년**이 지나, 비타민 B12 결핍과 빈혈·백혈구·혈소판 감소가 나타났습니다. 연자는 저장량 때문에 **8~10년 이상** 지나 드러나는 경우도 있다고 설명했습니다. 이는 검사를 그때까지 미루라는 뜻이 아닙니다.

아산 28회 연수강좌 — Hemoglobin(혈색소) 이상에 대한 접근(최은지)
광교바른내과 의원
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · 031-893-4560
평일(월–금) 08:30 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
토요일 08:30 – 13:30 · 일요일·공휴일 휴진
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

본 자료는 일반 안내입니다. 약의 시작·용량·중단은 위험도와 검사 결과를 보고 진료실에서 정하며, 약은 임의로 끊지 마시고 상의해 주세요.

나의 보충 치료와 다음 검사를 이어갑니다

원인을 확인한 뒤 투여 방법과 유지 치료를 정합니다. 처방 일정에 맞춰 기록해 두세요.

검사와 보충제는 역할이 다릅니다

검사·치료	어떻게 정하나요
혈액검사(CBC) · MCV	빈혈과 백혈구·혈소판 변화, 적혈구의 평균 크기를 함께 봅니다. MCV 정상 범위는 **80~100fL**, **>100fL**이면 큰 적혈구입니다.
비타민 B12 · 엽산 검사	둘은 서로 다른 결핍입니다. 검사 결과에 따라 B12 또는 엽산 치료를 정합니다.
철분제	**최은지 연자 Q&A:** 모두에게 함께 주는 것은 아니며 철 검사로 철결핍이 있으면 사용합니다. 위전절제 후에는 함께 필요할 수 있습니다.

강의에서 소개한 B12 주사 일정

교재: 시아노코발라민(cyanocobalamin) **1,000mcg 근육주사, 매주 4~8주** 후 **1~3개월마다** 유지합니다. 되돌릴 수 없는 원인이면 **평생 보충**합니다.
연자의 기관에서는 **매주 6주**, 이후 **3개월마다** 투여한다고 설명했습니다. 나의 처방 일정은 진료에서 정합니다.

먹는 약으로 바꿀 수 있을까요?

최은지 연자 Q&A

흡수장애가 원인인 경우가 많아 주사로 시작하는 경우가 많습니다. 다만 **빈혈·신경학적 증상이 심하지 않거나, B12 회복 후 유지 치료**에서는 고용량 경구 B12의 수동흡수를 이용할 수도 있다고 설명했습니다.

진료 기록

1. 수술 날짜·수술 범위: _____
2. 현재 B12 약·주사와 일정: _____
3. 다음 검사일·주사일: _____

광교바른내과 의원
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · 031-893-4560
평일(월–금) 08:30 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
토요일 08:30 – 13:30 · 일요일·공휴일 휴진
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

본 자료는 일반 안내입니다. 약의 시작·용량·중단은 위험도와 검사 결과를 보고 진료실에서 정하며, 약은 임의로 끊지 마시고 상의해 주세요.

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/hematology/gastrectomy-b12-care-asan28/